

Manifestaciones orales secundarias al tratamiento oncológico y protocolos odontológicos de actuación



Dra. Diana Rocío Orué

¿POR QUÉ SE HABLA TANTO DE LOS
PROBLEMAS BUCALES EN LOS
PACIENTES QUE RECIBEN
TRATAMIENTO CONTRA EL CÁNCER?



Porque los tratamientos oncológicos, como la quimioterapia y la radioterapia, aunque son esenciales para combatir el cáncer, también afectan a células sanas que se regeneran rápidamente, como las de la boca.

Esto puede provocar una serie de complicaciones locales y sistémicas: mucositis, sequedad bucal, infecciones, alteraciones del gusto, dificultad para abrir la boca y caries por radiación.

Son efectos secundarios que impactan directamente en la calidad de vida del paciente. Por eso, contar con un protocolo odontológico adecuado es fundamental para prevenirlos y mantener la salud oral durante todo el proceso oncológico.

¿QUÉ PAPEL CUMPLE EL ODONTÓLOGO ANTES DE QUE COMIENZE EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER?

El odontólogo tiene un rol clave desde el inicio. En la **fase pretratamiento**, su objetivo es preparar la boca para resistir los efectos de la quimio y la radioterapia.

Se realiza una evaluación integral, que incluye:

- Examen clínico detallado de dientes, encías y mucosas.
- Radiografías panorámicas e intraorales para detectar infecciones ocultas.
- Evaluación periodontal para medir la salud de las encías.
- Revisión de los valores de sangre y función hepática antes de hacer cualquier procedimiento invasivo.

Si hay dientes en mal estado o infecciones, se tratan o se extraen antes del inicio de la terapia. También se hace una limpieza profesional y se ajustan las prótesis mal adaptadas.

Además, se educa al paciente en higiene oral intensiva: cepillado con cepillo de cerdas suaves, uso de pastas fluoradas, enjuagues sin alcohol y dieta baja en azúcares.

Lo ideal es realizar todo esto dos o tres semanas antes de comenzar el tratamiento.

¿QUÉ PASA DURANTE LA QUIMIO O LA RADIOTERAPIA? ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES CUIDADOS EN ESA ETAPA?

Durante el tratamiento, las defensas del paciente suelen bajar, y eso aumenta el riesgo de infecciones y lesiones en la boca.

En esta fase durante el tratamiento oncológico, los problemas más comunes son:

- Mucositis oral: heridas dolorosas que dificultan comer o hablar.
- Infecciones bacterianas, virales o fúngicas.
- Sequedad bucal (xerostomía) y pérdida del gusto.
- Trismo y caries por radiación.



Para prevenir complicaciones, el paciente debe mantener una higiene suave pero constante:

- Cepillarse de 2 a 4 veces al día con cepillo ultrasuave y pasta con alto contenido de flúor.
- Usar hilo dental solo si no hay heridas en la mucosa.
- Aplicar flúor mediante férulas personalizadas.
- Utilizar enjuagues antibacterianos sin alcohol o con suero fisiológico.
- Mantener la boca hidratada y estimular la saliva con chicles sin azúcar o saliva artificial.

IMPORTANTE

Suspender cualquier procedimiento odontológico invasivo en momentos de **neutropenia o plaquetas bajas**, para evitar complicaciones.

En esta etapa, el odontólogo y el oncólogo deben trabajar de manera coordinada, adaptando los tiempos del tratamiento y revisando la mucosa oral semanalmente.



UNA VEZ QUE TERMINA EL TRATAMIENTO, ¿QUÉ CUIDADOS DEBE SEGUIR EL PACIENTE?



Esa es la fase postratamiento, y sigue siendo muy importante.

Aunque el tratamiento haya finalizado, pueden persistir efectos como la sequedad bucal, las caries o la enfermedad periodontal.

El control odontológico debe hacerse cada 1 a 3 meses durante los dos primeros años, y luego cada 3 a 6 meses, según la evolución del paciente.

Se refuerza la higiene oral, se aplican flúor tópicos y se toman radiografías de control.

Además, en pacientes que recibieron radioterapia en cabeza y cuello, hay que vigilar el riesgo de osteorradionecrosis, es decir, daño al hueso irradiado.

Si es necesario realizar extracciones o cirugías, deben hacerse con profilaxis antibiótica y siempre bajo control del oncólogo.

El seguimiento continuo permite prevenir complicaciones tardías y mejorar la función, la nutrición, el habla y la autoestima del paciente.

EN ALGUNOS ESTUDIOS SE MENCIONA UNA ESTRECHA RELACION
ENTRE LA ENFERMEDAD CRÓNICA Y EL CÁNCER DE MAMAS,
QUE SE SABE AL RESPECTO?



La enfermedad periodontal —que es la inflamación crónica de las encías— puede contribuir a la inflamación sistémica, y se está estudiando su posible relación con la evolución del cáncer de mama.

Además, algunas pacientes con cáncer de mama reciben tratamientos hormonales o bisfosfonatos, que pueden aumentar el riesgo de complicaciones orales.

Por eso, el control periodontal antes y después del tratamiento es esencial: reduce el riesgo de infecciones, dolor y pérdida ósea.

¿CÓMO DEBERÍA INTEGRARSE EL ODONTÓLOGO EN EL EQUIPO ONCOLÓGICO?



El odontólogo debe ser parte activa del equipo multidisciplinario.

Su papel abarca tres momentos fundamentales:

- 1. Prevención** (fase pretratamiento): eliminar infecciones, educar al paciente y preparar la cavidad oral.
- 2. Manejo** (fase durante el tratamiento): controlar la mucositis, infecciones y dolor.
- 3. Rehabilitación** (fase postratamiento): restaurar la función oral y prevenir complicaciones a largo plazo.

El trabajo conjunto con oncólogos, enfermeras, nutricionistas y psicólogos garantiza un abordaje integral del paciente y una mejor calidad de vida.

MENSAJE AL PACIENTE ONCOLÓGICO Y A SUS FAMILIARES

La salud bucal también es parte del tratamiento del cáncer.



Una boca sana no solo evita infecciones, sino que ayuda al paciente a alimentarse mejor, hablar sin dolor y sentirse más cómodo.

Por eso, es fundamental que los pacientes acudan a un odontólogo desde el primer momento y mantengan un seguimiento constante, incluso después de finalizar la terapia.

La prevención, la coordinación entre profesionales y la educación son las mejores herramientas para mejorar la calidad de vida durante y después del cáncer.

Referencia de apoyo

- Sabater Recolons MM et al. Manifestaciones orales secundarias al tratamiento oncológico. Avances en Odontoestomatología, 2006.
- Barrantes-Rafael JY et al. Relación entre la enfermedad periodontal y el cáncer de mama. Avances en Odontoestomatología, 2025.
- Salud bucal en pacientes con cáncer de mama: prevención y cuidado integral. Scielo.org.co, 2019.



Gracias

DRA. DIANA ROCÍO ORUÉ